SDD 312 Sujet n°1

Spécialité : Obstétrique

Date : 5/1/2025
Autrices : Clara LEMARCHAND (DES médecine générale, EN 2024), Chloë LESEIGNEUR (DES médecine générale, EN 2024)
Relecteur(s) : Lucie-Lou Vial, DES MAR Toulouse

Situation de départ	SDD 284 - CS de suivi et d'un ETP d'un pat
Objectif de connaissance	Item 243 - Hypothyroïdie
Attendu d'apprentissage spécifique Attendu d'apprentissage dans la famille	- Entretien, interrogatoire - Stratégie diagnostique
Auteur	Alex, Camille
Domaine	**Endocrinologie-nutrition**

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes endocrinologue dans un cabinet en ville et vous recevez Mme T., 45 ans, qui vous a été adressée par son médecin généraliste pour une asthénie.

Elle vous consulte munie d'un bilan biologique prescrit par son médecin traitant.

Consignes :
Vous devez en 8 minutes :

- ➔ interpréter à l'examinateur le bilan biologique
- ➔ réaliser une anamnèse ciblée étiologique et symptomatologique
- ➔ proposer à la patiente des examens complémentaires adaptés

Vous ne devez pas :

- Réaliser un examen physique

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec patient standardisé.

Instructions au patient standardisé

IDENTITÉ / CONTEXTE

- Mame T., 45 ans
- 3 enfants
- Commerciale chez Citroën
- Taille : 150 cm Poids : 80 kg IMC 35.5 kg/m²

ANTÉCÉDENTS

- Vitiligo non invalidant et non traité depuis 10 ans
- Amygdalectomie à 16 ans

MÉDICAMENTS ACTUELS

0

MOTIF DE LA VENUE

Asthénie depuis 3 mois.

HISTOIRE ACTUELLE

Vous êtes fatiguée depuis 3 mois. Vous n'arrivez pas à travailler malgré votre travail passionnant. Votre mari vous prend la tête car vous ne vous occupez pas des enfants.

Vous avez consulté votre médecin généraliste qui vous a prescrit un bilan biologique et vous a adressé à un.e endocrinologue. Vous n'avez pas d'informations sur les diagnostics évoqués.

SYMPTÔMES

- Asthénie et anorexie depuis 3 mois
- Constipation depuis 3 mois
- Frilosité depuis 3 mois
- Prise de poids de 10 kg en 3 mois
- Troubles de la libido depuis 3 mois
- Troubles de la concentration

Pas de crampes, pas de myalgies, pas de raideur
Pas de malaise, pas de lipothymie, pas de dyspnée
Pas de galactorrhée

ETAT D'ESPRIT/COMPORTEMENT

- Fatiguée, un peu déprimée

QUESTIONS A POSER AU MÉDECIN

- Si l'étudiant n'a pas prescrit d'examens complémentaires au bout de 6 min 30, dire "que dois-je faire maintenant docteur ?"

Bilan biologique

NFS-plaquettes :

Hémoglobine (g/dL)	14 *(12-16)*
Leucocytes (G/L)	7 *(4-10)*
Plaquettes (G/L)	260 *(150-450)*

Bilan hormonal :

TSHus (mUI/L)	**8** (0.4-4)
T4 libre (ng/L)	**5** (9-17)

Grille d'évaluation

OBJECTIFS CIBLÉS		
Compétence générique	**Item évalué**	**Non-observé : 0 Observé : 1**
Synthèse d'examens complémentaires	Évoque une **hypothyroïdie** d'origine **périphérique** (les deux éléments sont à évoquer pour avoir le point). • *« Hypothyroïdie d'origine primaire » acceptée*	0 - 1
Anamnèse	Recherche des antécédents personnels et familiaux de **dysthyroïdie**.	0 - 1
	Recherche des **éléments étiologiques** parmi : - des antécédents personnels et familiaux de maladie auto-immune (cf. annexe) - une grossesse récente - une chirurgie thyroïdienne - une prise médicamenteuse (au moins *2 éléments sur 4*)	0 - 1
	Recherche une **prise de poids**.	0 - 1
	Recherche une **frilosité/hypothermie.**	0 - 1
	Recherche une **constipation**.	0 - 1
	Recherche une **aménorrhée** ou des **troubles de la libido**.	0 - 1
	Recherche un **syndrome dépressif** ou un **ralentissement psychomoteur**, ou une **somnolence**.	0 - 1
Stratégie diagnostique	Prescription d'une **échographie thyroïdienne**.	0 - 1
	Prescription d'**anticorps anti-TPO** (thyroperoxydase)	0 - 1
	TOTAL OBJECTIFS CIBLÉS	**/ 10**

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

1. **APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair**

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

5. COMMUNICATION NON VERBALE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

11. APTITUDE À PLANIFIER LES SOINS (= approche centrée sur le patient)

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Le projet des soins ne correspond pas au tableau clinique ou ne prend pas en compte le patient et ses besoins	Le projet des soins est adapté au tableau clinique Omet quelque fois de prendre en compte les capacités / contraintes du patient	Fait participer le patient à la planification de ses soins *(ex invite le patient à poser des questions)*	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient.	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient. Renforce la confiance du patient et son autonomie

TOTAL OBJECTIFS GÉNÉRAUX	**/ 5**
TOTAL	**/ 15**

Annexe :

Certaines maladies auto-immunes peuvent être associées aux thyroïdites (syndrome de polyendocrinopathies auto-immunes). On peut donc rechercher :

- Vitiligo
- Insuffisance surrenalienne (maladie d'Addison)
- maladie cœliaque
- maladie de Biermer
- diabete de type 1

Petit rappel sur les dysthyroïdies

Cliniquement :

+	- Asthénie, ↓ poids, polyphagie - Thermophobie, sueurs, moiteurs, polydipsie	- Palpitations - Dyspnée d'effort	- Nervosité, tr. sommeil - Tremblements	- Polyexonération - Prurit	- Leuconeutropénie (↑ ly relative) - Hypergly, hyperCa - ↓ chol TG - ↑ ASAT/ALAT, PAL
	- Hyperthermie, mains chaudes et moites - HTA	- Souffle systolique de débit	- Orbitopathie si BDW (DERCH) - Amyotrophie	- Gynécomastie	
-	- Asthénie, ↑ poids, anorexie - Frilosité		- Somnolence - Raideur, crampes, myalgies	- Constipation - Tr. libido et règles - Rare galactorrhée	- Anémie - HypoNa - ↑ chol et TG - ↑ CPK, LDH, ASAT
	- Hypothermie	- Bradycardie		- Myxoedème si périph (larynx, langue, trompbe d'Eustache, faciès lunaire, dos mains et pieds) - Peau pâle et jaunâtre, sèche, dépilée (queue du sourcil), désudée - Cheveux secs et cassants	

Attention à la **cardiothyréose** en cas d'hyperT4 (troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque).

Etiologies :
Pour les causes centrales, cf. tout ce qui peut toucher l'hypothalamus ou l'hypophyse (adénome, méningite, hypophysite, tumeur etc…)

	Hypothyroïdie périphérique	Hyperthyroïdie périphérique
Causes auto-immunes (ATCD pers/fam)	- Hashimoto (TPO/Tg) - Post-partum	- Basedow (TRAK = R-TSH) - Post-partum
Causes iatrogènes	- Médicamenteux (lithium, amiodarone, immunothérapie anti PD1/CTLA4) - Radiothérapie pour l'hypothyroïdie	
Autres	- Carence en iode - Thyroïdite de De Quervain - Congénital	- Goitre autonome, adénome - Thyroïdite de De Quervain - Thyrotoxicose gestationnelle transitoire

Biologiquement :

	Hypothyroïdie		Hyperthyroïdie	
	Central	Périphérique	Central	Périphérique
T4L	↘	N ou ↘	↗	↗
TSH	N ou ↘	↗	N ou ↗	↘

Traitement :

	Hypothyroïdie	Hyperthyroïdie
Médicamenteux	- L-T4 en comprimés (rare solution ou injection)	- Antithyroïdiens de synthèse en comprimés
Associés		- Bêta-bloquants - Sédatifs - Repos - Contraception chez la femme en âge de procréer
Suivi	Central : T4L à J15-J21 à jeun (avant la prise de LT4 du matin) Périphérique : TSH tous les 2 mois puis 6 mois lorsque stabilisée - obj : 0.5-2.5 (+ si coronarien pour éviter thyrotoxicose)	- T4 libre à 3-4 semaine puis TSH tous les 3 mois - Dépistage de l'agranulocytose : NFS tous les 10 jours pendant 2 mois, mentionner sur l'ordo d'arrêter le traitement en cas de fièvre

Alternatives aux ATS : la radiothérapie et la chirurgie
Ces deux nécéssitent une préparation préalable par ATS pour établir une euthyroïdie.

	Avantages	Inconvénients
Traitement médical par ATS	Non invasif Rémission (40–50 %) Coût	Taux de rechute élevé Longueur du traitement
Iode 131	Non invasif Efficace Faible taux de récidive	Délai d'action Délai avant grossesse Hypothyroïdie définitive Risque de majoration du taux des TRAK et d'accentuation d'une orbitopathie
Chirurgie	Rapidité d'effet Efficacité	Équipe chirurgicale entraînée Possibles complications postopératoires Hypothyroïdie définitive

La radiothérapie nécessite un délai avant grossesse de 6 mois